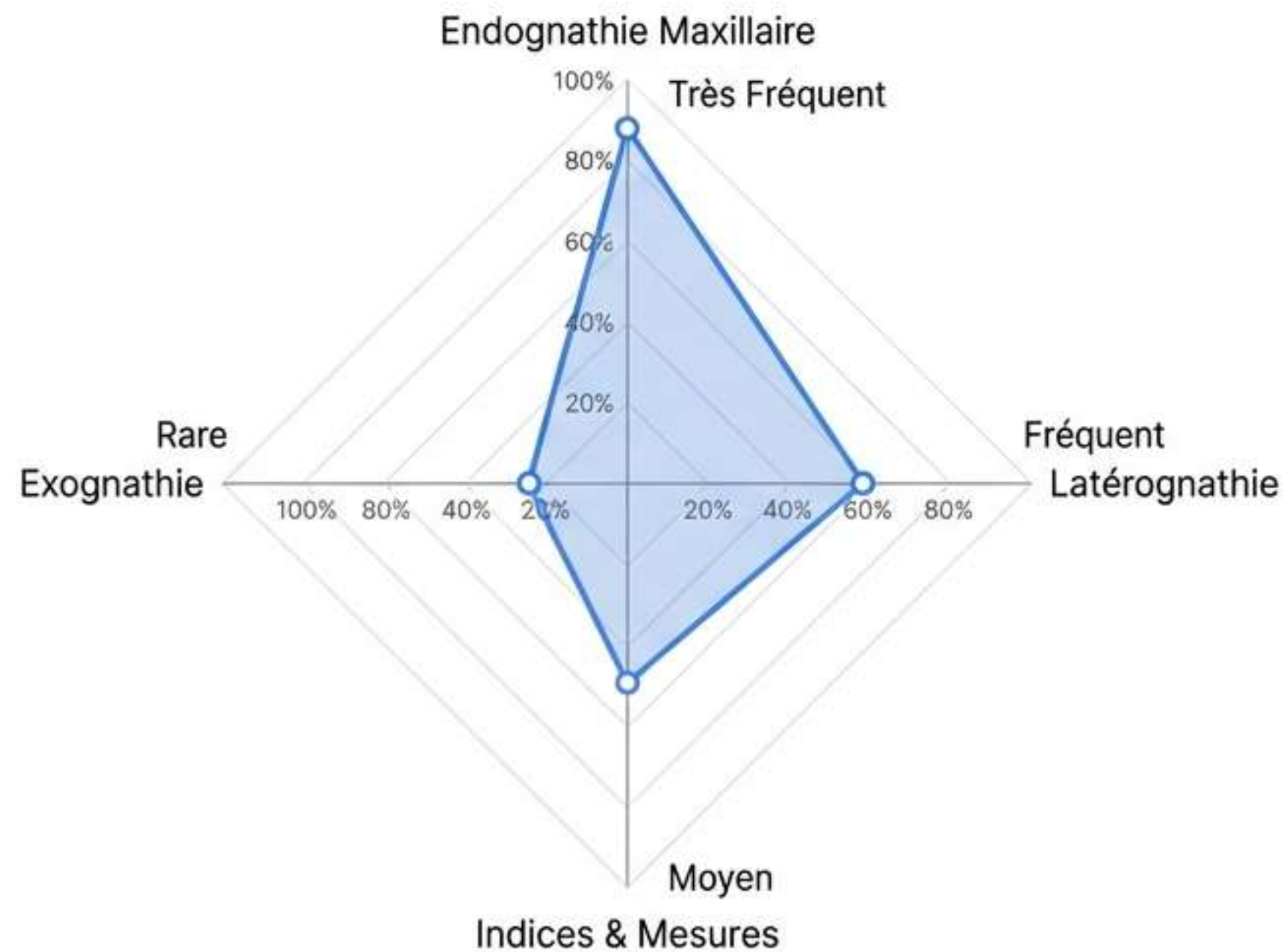


Analyse des Tendances d'Examen

Stratégie de Révision : Anomalies Transversales



L'Endognathie Maxillaire (Symétrique & Asymétrique)

~60% des questions d'examen. Focus majeur : signes cliniques, association fentes, diagnostic différentiel.

Latérogathie Mandibulaire

Point clé : Le 'Chemin de fermeture' est strictement **DROIT** [Ref: Q12 2025]. Ne pas confondre avec la latéro-déviation.

Exognathie Mandibulaire : Sujet peu testé. Probabilité élevée de question sur la définition/étiologie [Predicted].
Lignes de Référence : Les lignes horizontales (ophriaque, etc.) sont fondamentales [Predicted].

Protocole de Diagnostic : Structure du Cours

```
graph TD; Root[Protocole de Diagnostic : Structure du Cours] --- I[I. DÉFINITION - RAPPELS]; Root --- II[II. ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC]; Root --- III[III. FORMES CLINIQUES]; I --- I1[• Classification des anomalies]; I --- I2[• Définition des anomalies basales (Sens Transversal)]; II --- II1[• Anamnèse]; II --- II2[• Examen Clinique (Exo-buccal, Endo-buccal, Fonctionnel)]; II --- II3[• Examens Complémentaires (Photo, Moulage, Radio)]; III --- III1[• Endognathie Maxillaire (Sym/Asym)]; III --- III2[• Endognathie Mandibulaire]; III --- III3[• Exognathie Maxillaire]; III --- III4[• Exognathie Mandibulaire]; III --- III5[• Latérogathie Mandibulaire];
```

I. DÉFINITION - RAPPELS

- Classification des anomalies
- Définition des anomalies basales (Sens Transversal)

II. ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Anamnèse
- Examen Clinique (Exo-buccal, Endo-buccal, Fonctionnel)
- Examens Complémentaires (Photo, Moulage, Radio)

III. FORMES CLINIQUES

- Endognathie Maxillaire (Sym/Asym)
- Endognathie Mandibulaire
- Exognathie Maxillaire
- Exognathie Mandibulaire
- Latérogathie Mandibulaire

I. Définition et Classification

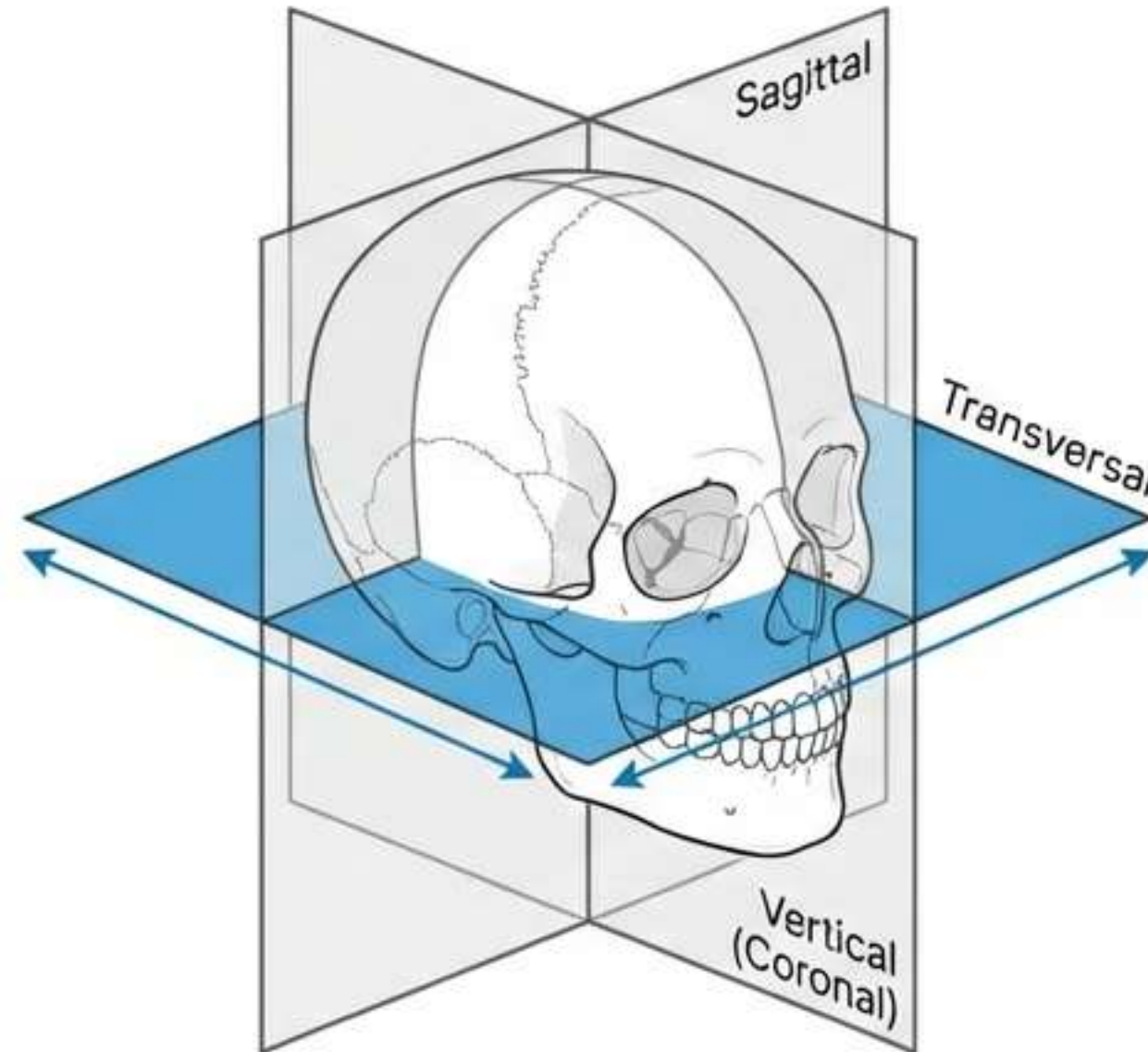
Définition Générale

Variations morphologiques et fonctionnelles de la sphère oro-faciale.

Conséquences : Troubles esthétiques, fonctionnels et occlusaux.

Classification :

1. Anomalies des bases (décalage)
2. Anomalies des procès alvéolaires (hauteur/direction)
3. Anomalies dentaires (volume, nombre, position)



Anomalies Basales Transversales

Touchent le maxillaire et/ou la mandibule.

Deux formes cliniques :

1. Insuffisance (Endognathie) :
Dysharmonie maxillo-mandibulaire. Risque d'anomalie cinétique : la latérodéviation mandibulaire.
(Highlight Yellow: [Ref: Q1, Q18])
2. Excès (Exognathie) :
Maxillaire et/ou mandibulaire.

II. Diagnostic : L'Anamnèse



Hérédité



Antécédents



Habitudes



Respiration

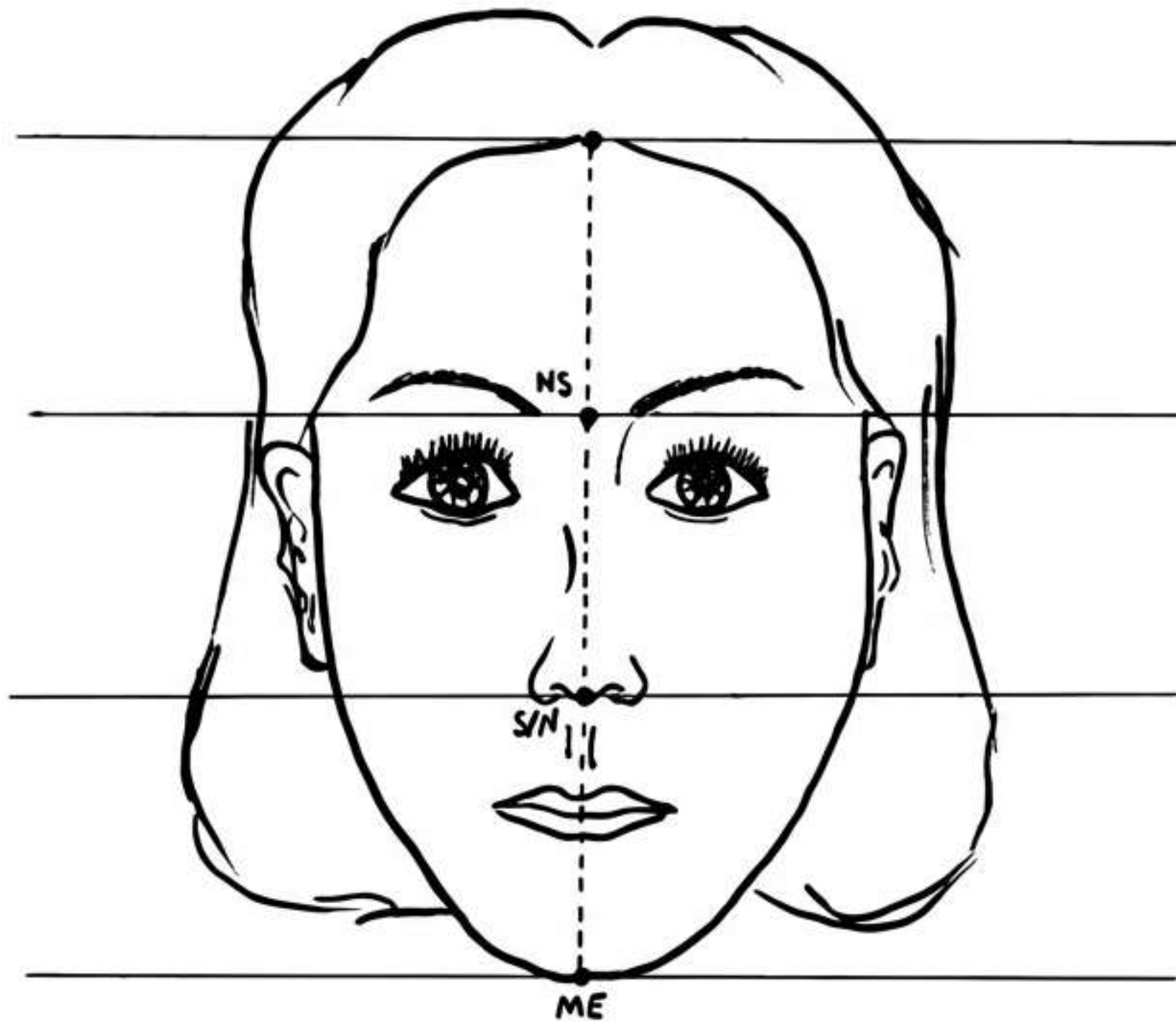
- **Âge & Hérédité**
- **Antécédents médicaux :**
Traumatismes, maladies petite enfance.
- **Antécédents dentaires :**
Caries, extractions précoces.

- **Habitudes déformantes :**
Succion digitale, linguale ou labiale.
- **Troubles de la respiration :**
Amygdales hypertrophiques, végétations adénoïdes.

Note Examen - Respiration :

Une respiration buccale peut aggraver une endognathie débutante ou être causée par une endognathie sévère. Influence directe sur le sens transversal. [Ref: Q18 2025]

Examen Clinique : Exo-buccal (Visage)

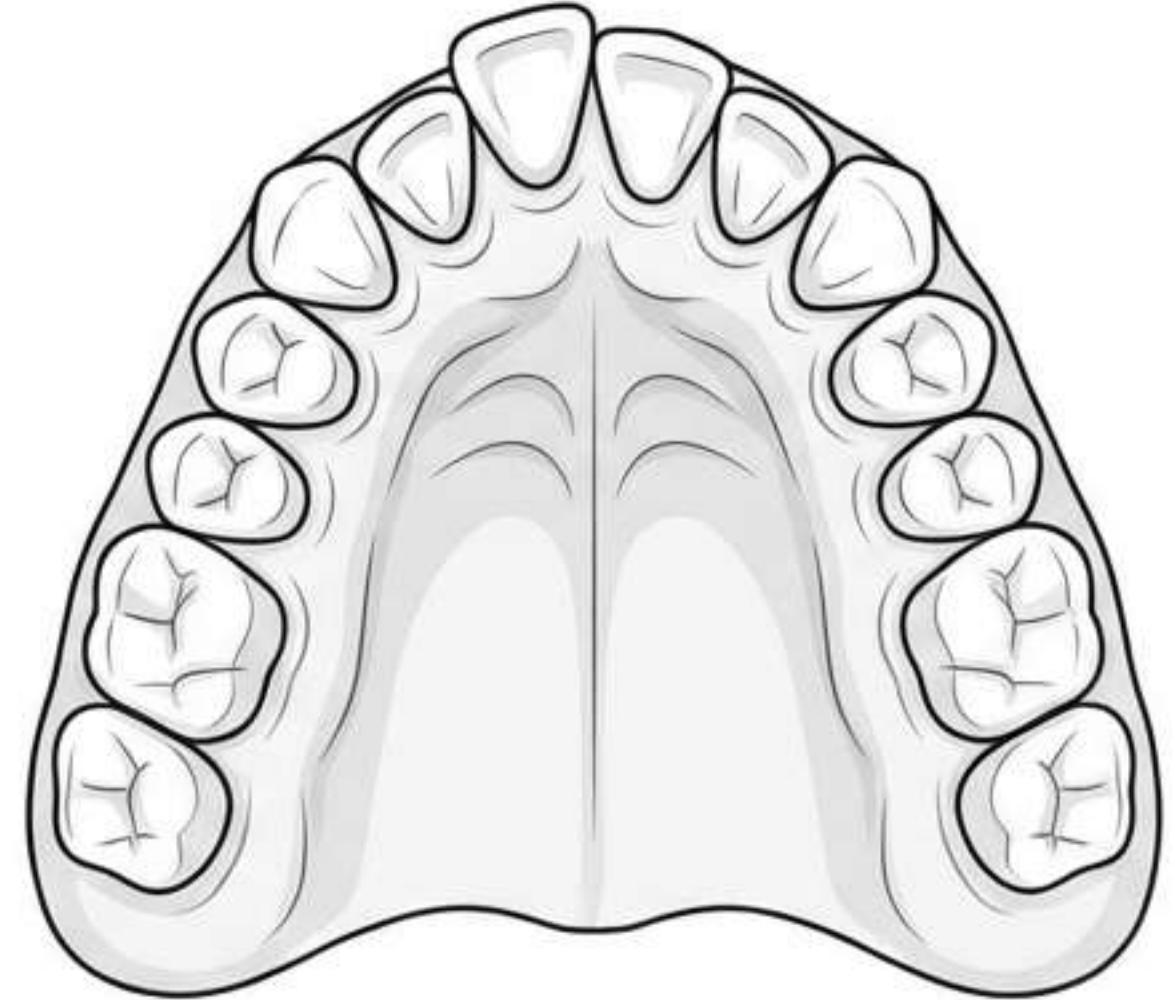
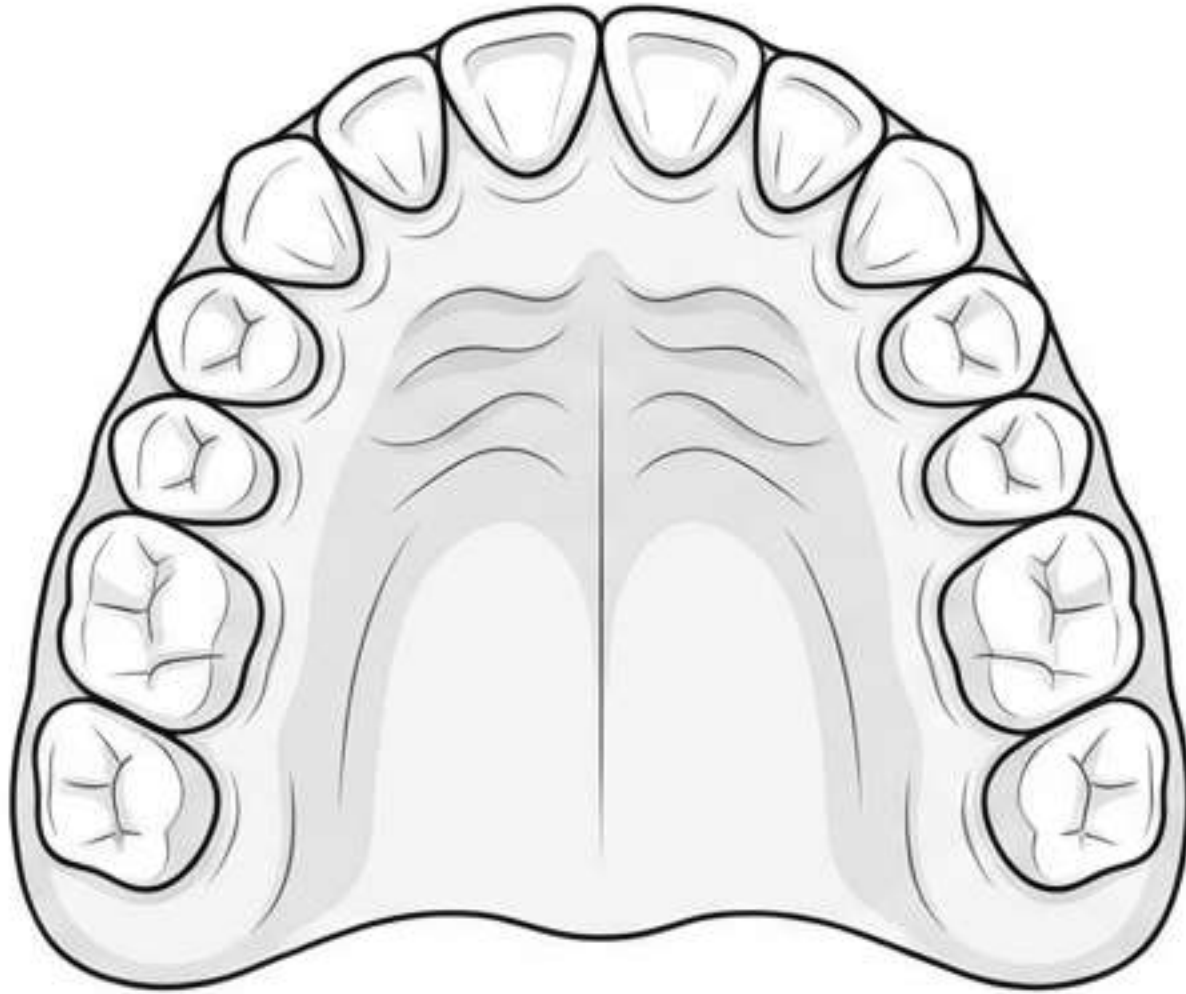


Observation de Face

- Forme générale crânio-faciale.
- **Symétrie** : Face / Plan Sagittal Médian (PSM).
- **Parallélisme** : Arcades sourcilières et yeux.
- **Nez** : Forme et largeur des narines.
- **Structure** : Forme des apophyses zygomatiques, relief des joues.
- **Bouche** : Symétrie des lèvres / PSM.
- **Sourire** : Largeur du maxillaire.
- **Menton** : Position.

Palpation : Procéder à une palpation musculaire (lèvres, joues, masséters) et examen des ATM. [Predicted – Clinical Procedure]

Examen Clinique : Endo-buccal



1. Arcades

- Forme (V ou U) et Dimension.
- Voûte palatine (Ogivale ?).
- Rapport des arcades.

2. Symétrie

- Hémi-arcades / Raphé médian.
- Freins (lingual et labial inférieur).

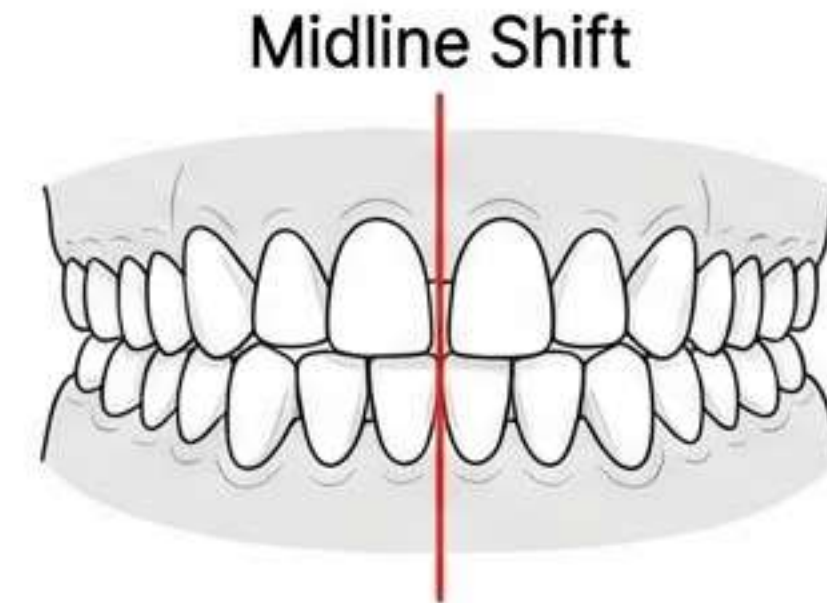
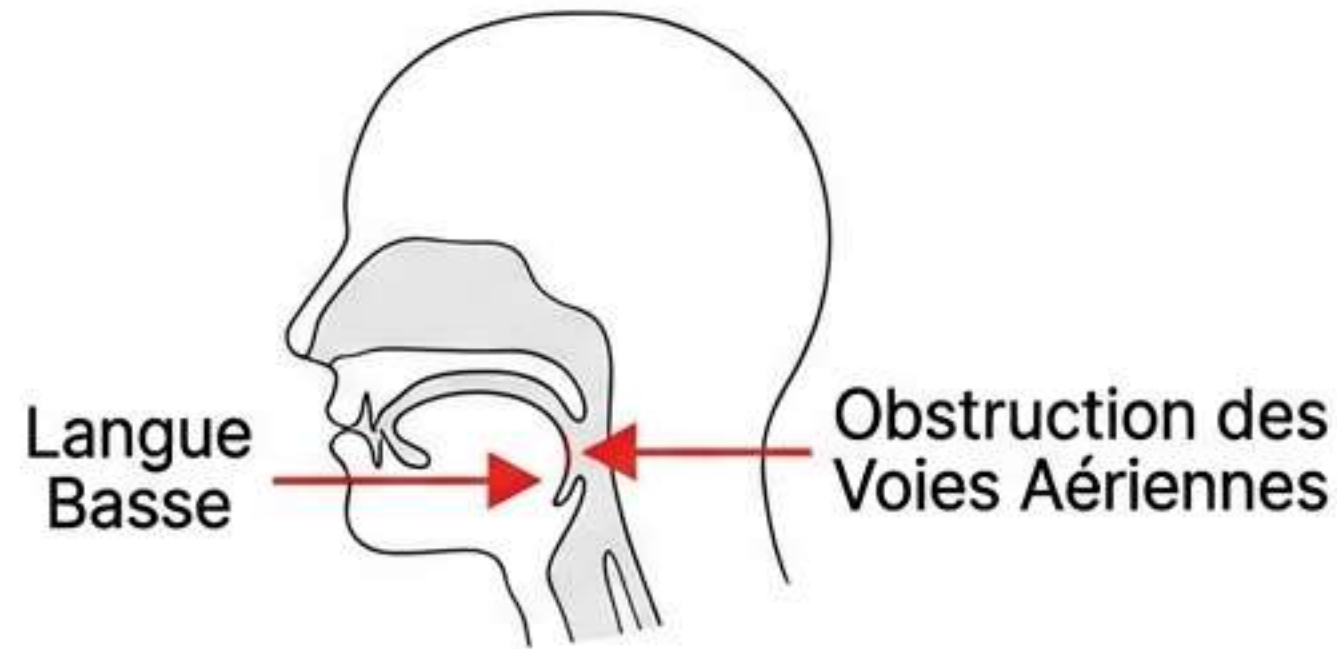
3. Procès Alvéolaires

- Déformations ou inclinaisons.
 - Note : Compensation alvéolaire possible si non-concordance transversale.

4. Dents

- Anomalies de nombre, forme, volume (se superposent aux anomalies squelettiques).

Examen Fonctionnel & Occlusal



Fonctions

Langue : Morphologie, volume, posture (repos/déglutition), frein.

Dysfonctions :

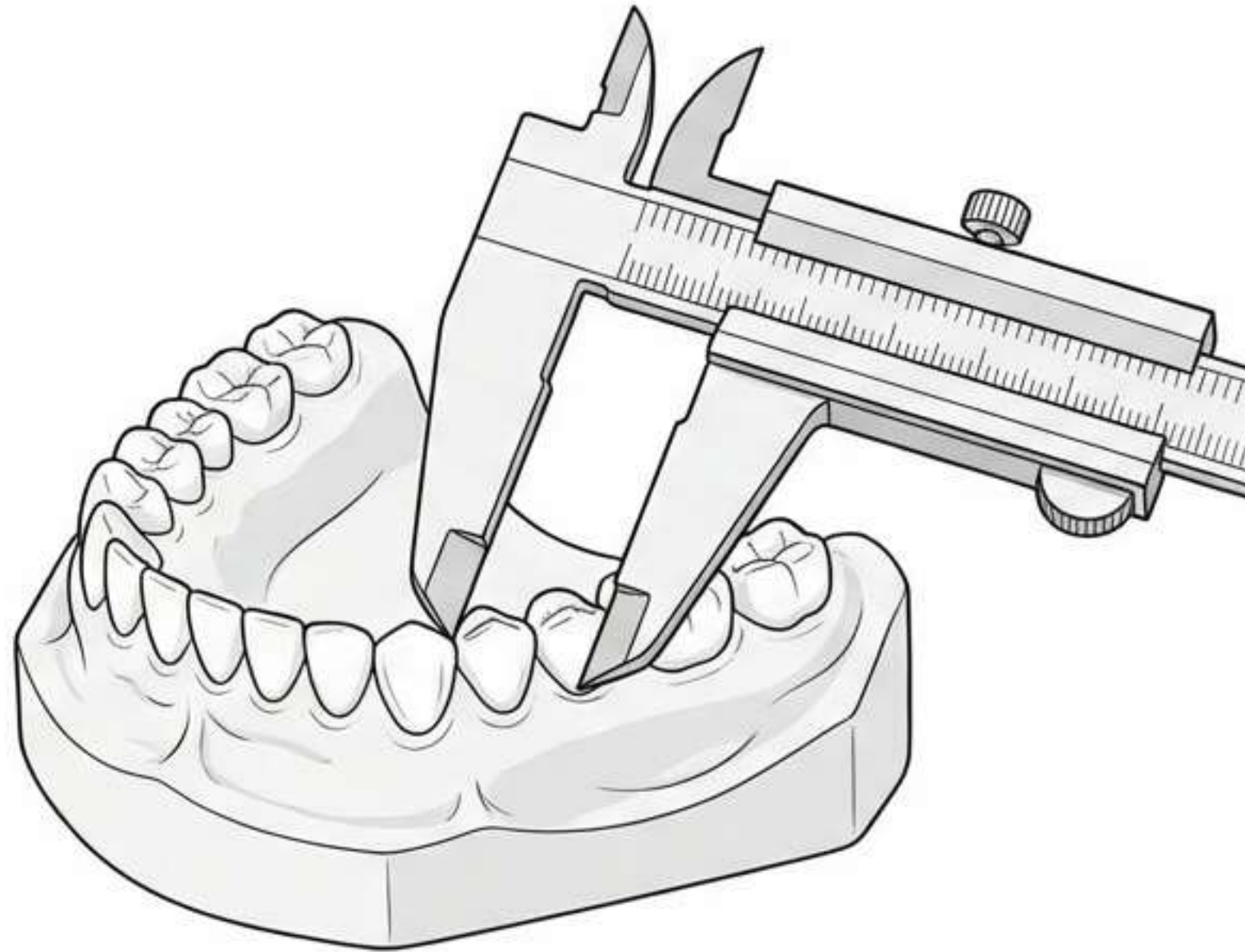
- Respiration buccale (langue basse, amygdales hypertrophiques). [Ref: Q18]
- Déglutition atypique.
- Problèmes de mastication.

Rapports Occlusaux

Statique & Dynamique :

- Occlusion incisive, canine, molaire, secteurs latéraux.
- Continuité des arcades.
- **Chemin de fermeture** (Crucial pour le diagnostic différentiel).
- Pente incisive en propulsion.
- Protection canine ou de groupe en latéralité.

Examens Complémentaires



1. Photographies (Face & Profil)

Mensurations basées sur le PSM.

Lignes horizontales (parallèles entre elles et perpendiculaires au PSM) : (Predicted – List Memorization)]

- Ligne ophriaque
- Ligne bipupillaire
- Ligne sous-nasale
- Ligne bicommissurale

2. Moulages

Examen des arcades (Courbe de Spee, Wilson, Forme V/U).

Indices de mensuration (Diagnostic alvéolaire ou osseux) :

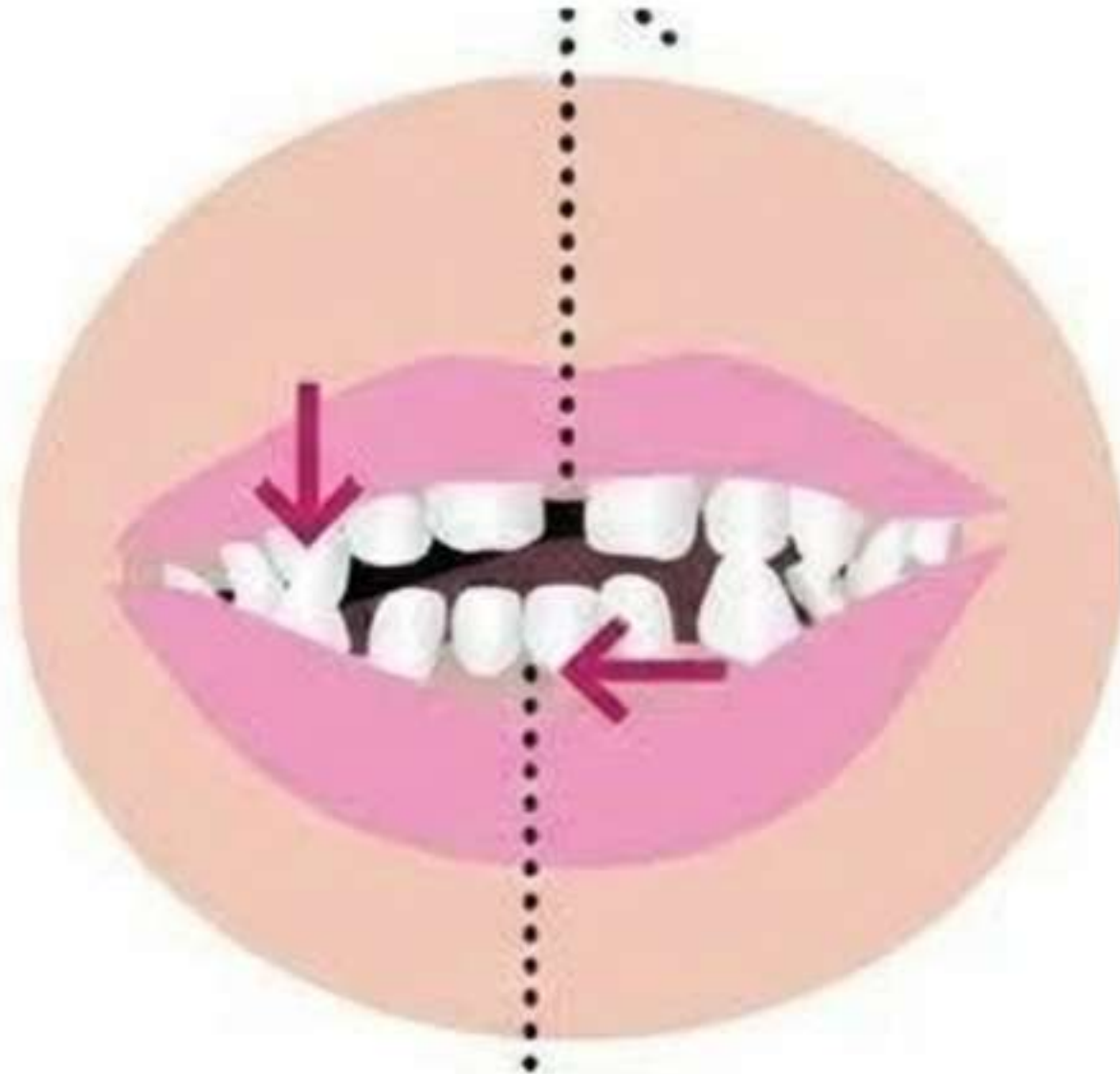
- Indice de Pont
- Indice de Château
- Indice d'Izard (Ref : Q19 2025)]

3. Radiographies

Panoramique : Symétrie nasale et maxillo-mandibulaire / PSM.

Téléradiographie : Incidence frontale et axiale.

III. L'Endognathie Maxillaire



Définition : Insuffisance de développement du maxillaire dans le sens transversal. [Ref: Q1 2021]

Caractéristique Clé : Inclinaison normale des Prémolaires (PM) et Molaires (M). [Ref: Q1 2021]

Association : Souvent associée à un encombrement antérieur. [Ref: Q1 2021]

- Peut être Symétrique. [Ref: Q6 2024]
- Peut être Asymétrique. [Ref: Q6 2024]
- Peut être Unilatérale ou Bilatérale. [Ref: Q6 2024]

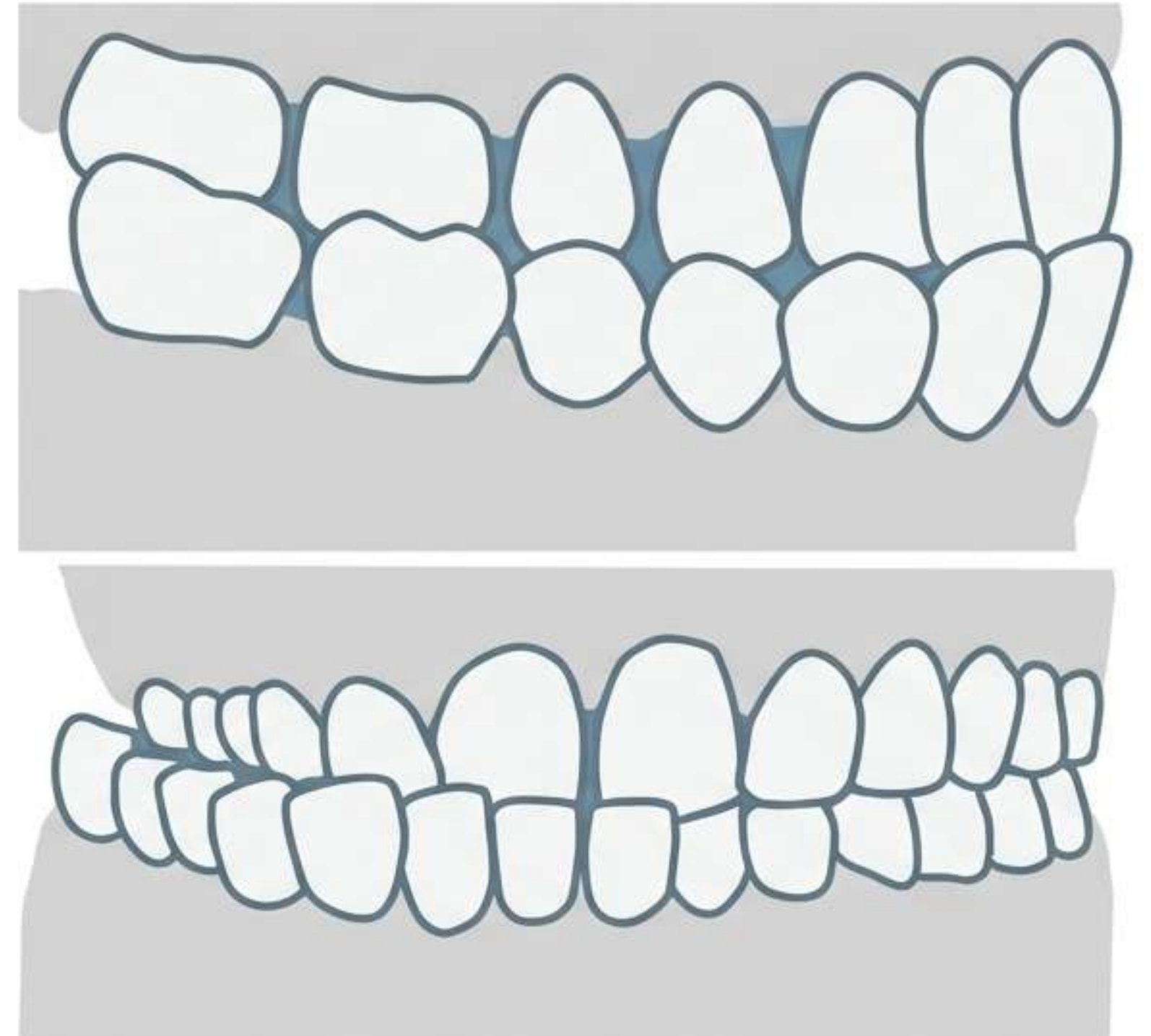
A. Endognathie Maxillaire Symétrique (Signes)

Signes Faciaux

- **Peu ou pas** de signes faciaux (sauf si associée à d'autres malocclusions). [Ref: Q2 2021]
- **Cas Sévères** : Allongement de la face marqué possible. [Ref: Q2 2021, Q16 2020]

Signes Occlusaux

- **Voûte Palatine** : Symétrique et ogivale. [Ref: Q2 2021]
- **Indice d'Izard** : Diminué. [Ref: Q19 2025]
- **Arcade Mandibulaire** : Normale. [Ref: Q16 2020]
- **Occlusion** : Croisée unilatérale (avec latéro-déviation) OU Bilatérale sans latéro-déviation.
- **Milieux Incisifs** : Coïncident au repos et en ICM (sauf déviation du chemin de fermeture). [Ref: Q10 2023, Q16 2020]



Endognathie Maxillaire Symétrique (Fonction & Étiologie)

Helvetica Now Display Signes Fonctionnels

- Interposition linguale entre les arcades (déglutition).
- **Ventilation** : Buccale ou mixte (Obstruction des voies aériennes, langue basse).

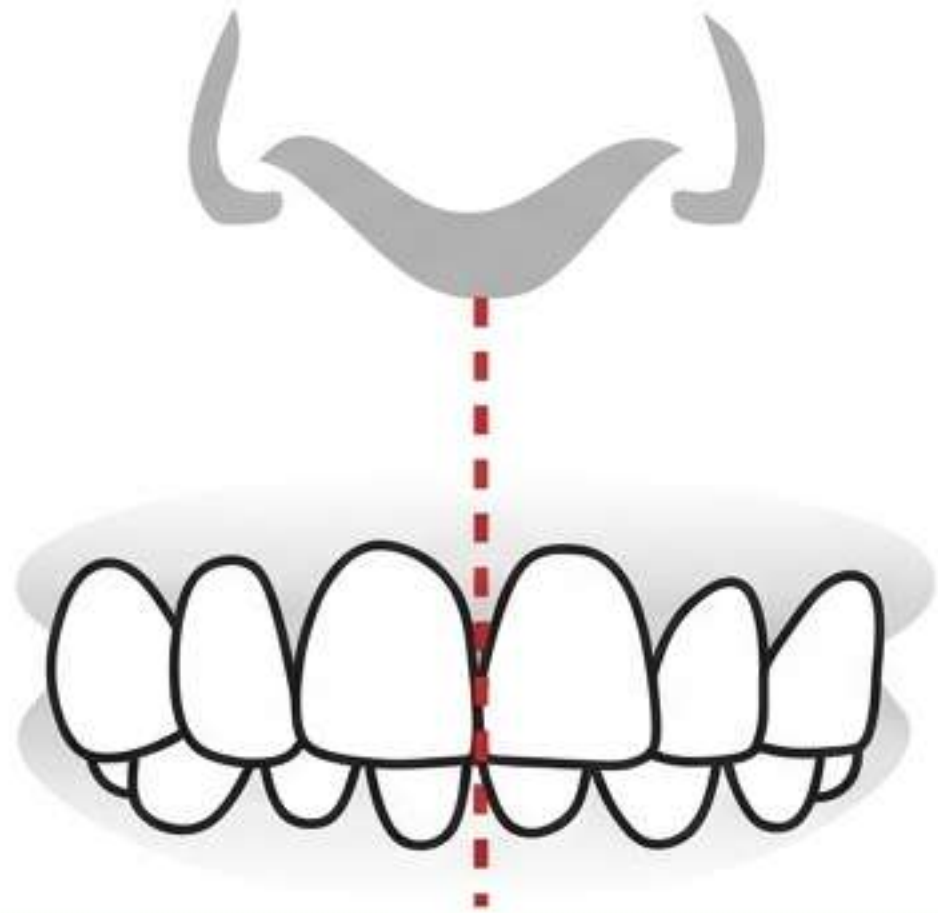
Helvetica Now Display Facteurs Étiologiques

- Hérité, Malformation congénitale génétique.
- Dysfonctions linguales (repos/déglutition/phonation).
- Troubles respiratoires (Obstruction).
- Troubles de la mastication.
- Succion digitale.

Helvetica Now Display Diagnostic Différentiel

- Endoalvéolie maxillaire.
- Exoalvéolie ou exognathie mandibulaire. [Ref: Q19 2025]

B. Endognathie Maxillaire Asymétrique



Asymmetric

Contexte Clinique

Se rencontre surtout dans les cas de **fentes labio-palatines**.
[Ref: Q2 2019, Q19 2019]

Signes Cliniques

- **Voûte Palatine** : Asymétrique. [Ref: Q3 2021, Q5 2020]
- **Occlusion** : Articulé croisé unilatéral (linguocclusion côté atteint). [Ref: Q3 2021, Q19 2019]
- **Important** : SANS latéro-déviation mandibulaire (coïncidence des points incisifs).
- **Face** : Déformation par aplatissement du côté atteint. [Ref: Q3 2021, Q5 2020]
- **Lignes** : Convergence des lignes sourcilières et commissurales du côté sain. [Ref: Q3 2021, Q5 2020]

C. Endognathie Mandibulaire

Caractéristiques

- Anomalie peu fréquente.
- Correspond à une mandibule de volume réduit et en rétroposition.
- Ou à une compensation d'une endognathie maxillaire.
- **Étiologie** : Lien possible avec posture linguale haute.

Diagnostic Différentiel

- Endoalvéolie mandibulaire.
- Endognathie maxillaire.
- Exoalvéolie maxillaire.
- Exognathie maxillaire. [Ref: Q12 2023]

D. Exognathie Maxillaire

Définition

Excès de développement du maxillaire dans le sens transversal.

Signes Faciaux

- Face large avec diminution de l'étage inférieur. [Ref: Q7 2020]
- Pommettes saillantes.
- Profil plat ou concave.

Signes Occlusaux

- Arcade large, Palais peu profond.
- Vestibulo-version ou palato-version des secteurs latéraux.
- **Supracluse importante voire vraie.** [Ref: Q7 2020]
- Mandibule inscrite dans le maxillaire.

Étiologie

Hérédité,
Macroglossie (langue haute),
Expansion excessive iatrogène.

E. Exognathie Mandibulaire

Définition & Étiologie

- **Définition** : Anomalie rare.
Mandibule trop large dans le sens transversal.
- **Étiologie** : Langue volumineuse et basse.

Diagnostic Différentiel

- L'endoalvéolie ou endognathie supérieure.
- L'exoalvéolie inférieure.

F. La Latérogathie Mandibulaire (Structurelle)

Définition

Anomalie basale caractérisée par une asymétrie de **forme** de la mandibule (déformation structurale). [Ref: Q3 2019]

Point Majeur - Cinétique

- **Chemin de fermeture est DROIT** (Pas de déviation). [Ref: Q12 2025]
- **Proglissement** : ABSENT. [Ref: Q12 2025]

Caractéristiques Cliniques

- Occlusion inversée unilatérale.
- Milieux incisifs déviés en ICM **ET** en RC.
- **Esthétique** : PSM dévié à partir du point sous-nasal.
- **Radio** : Non coïncidence des hémimandibules.

Facteurs Étiologiques

- Hérité / Congénital (Hémi-atrophie enfance). [Ref: Q3 2019]
- Troubles de croissance, Pathologies articulaires, Atteintes neuro-musculaires. [Ref: Q13 2023]

Diagnostic Différentiel : La Latéro-déviat

Définition

C'est une anomalie **cinétique** due à un trouble occlusal (contacts prématurés).

Comparaison Fondamentale :

Latérogathie (Squelettique)	Latéro-déviat (Fonctionnelle)
Asymétrie visible au Repos .	Asymétrie visible en occlusion, pas au repos .
Chemin de fermeture DROIT .	Chemin de fermeture DÉVIÉ .
Cause : Forme osseuse.	Cause : Prématurité, Endognathie Maxillaire. [Ref: Q14 2024]

Synthèse : Carte Mentale (Mind Map)

